



Distrito Córdoba y Guadalquivir
Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN

CARDIOLOGÍA – ATENCIÓN PRIMARIA

V02_Septiembre 2022

**HOSPITAL REINA SOFIA -
DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA-GUADALQUIVIR**

Con el objeto de mejorar la comunicación entre la UGC de Cardiología del Hospital Reina Sofía y las distintas UGCs del Distrito Córdoba y Guadalquivir, se ha establecido un grupo de trabajo con profesionales de los dos ámbitos asistenciales, que además de dar respuesta a las incidencias que se generan en la práctica diaria, garantice la mejora en la calidad asistencial en los pacientes.

Para ello, se establecen unos criterios de derivación por parte de Atención Primaria que permitan la actuación en acto único por parte de Atención Hospitalaria, y a su vez mejoren la comunicación y resolución de incidencias entre ambos niveles asistenciales, evitando que se generen consultas innecesarias y repetición de trámites administrativos ajenos a su práctica asistencial.

Para ello, se establecen los siguientes grupos de patología por motivos de consulta.

1.- INSUFICIENCIA CARDIACA Y DISNEA

Como cualquier otra patología crónica, el manejo de la Insuficiencia Cardíaca (IC) va a recaer en gran medida sobre atención primaria, si bien es importante detectar y reconocer aquellos casos que se van a poder beneficiar de una valoración en atención hospitalaria para realizar de un estudio etiológico más completo, así como una optimización del tratamiento en pacientes con mala evolución.

La **sospecha de clínica** se base en la presencia de 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores, siendo la disnea el síntoma más típico de la IC izquierda y el primero en aparecer.

<u>Criterios mayores</u>	Disnea paroxística nocturna Ingurgitación yugular Estertores crepitantes Cardiomegalia radiológica Edema agudo de pulmón radiológico Galope por tercer ruido Presión venosa central >16 mmHg Tiempo de circulación >25 s Reflujo hepatoyugular Pérdida de 4,5kg en 5 días en respuesta al tratamiento diurético
<u>Criterios menores</u>	Edemas maleolares Tos nocturna Disnea de esfuerzo Menos de un tercio de la capacidad vital Hepatomegalia Derrame pleural radiológico Taquicardia (>120 lpm)

Los pacientes con IC se **clasifican** desde el punto de vista funcional en:

Clase I. Ausencia de síntomas y de limitación funcional

Clase II. Síntomas o limitación funcional.

Actividades ordinarias producen disnea: Subir cuestras/Subir más de 2 pisos/Correr o caminar de prisa en plano/Llevar peso significativo/Coito

Clase III. Síntomas importantes o marcada limitación funcional.

Actividades menores de las ordinarias ocasionan disnea: Caminar a paso normal en plano/Subir menos de 2 pisos/Vestirse o desnudarse/Ducharse o secarse

Clase IV. Síntomas graves o limitación funcional grave.

Síntomas con cualquier tipo de esfuerzo o en reposo: Hablar, levantarse de la cama/Disnea paroxística nocturna/Ortopnea franca

Como **pruebas complementarias** de apoyo a la sospecha diagnóstica, en Atención Primaria, podemos contar con:

Exploración	Finalidad
Radiografía de tórax	Confirmar el diagnóstico de congestión o edema de pulmón Valorar cardiomegalia
Electrocardiograma	Detectar arritmias, evidenciar infartos anteriores, identificar hipertrofia ventricular izquierda
Hemograma, bioquímica, hormonas tiroideas	Excluir causas subyacentes y detectar complicaciones o comorbilidades
Péptidos natriuréticos	Diagnóstico (un valor normal excluye el origen cardíaco como causa de la disnea), seguimiento y pronóstico

Por su parte, Atención Primaria se centrará en tratar de evitar los episodios de descompensación en aquellos pacientes diagnosticados de IC. El agravamiento gradual de los signos y síntomas de congestión, el deterioro de biomarcadores como los péptidos natriuréticos o los parámetros de función renal, la necesidad creciente de diuréticos o la intolerancia a la medicación para la IC, son las características distintivas del agravamiento y, por tanto, de un episodio inminente de descompensación que puede beneficiarse de una **consulta con Atención Hospitalaria y la utilización del Hospital de Día de Insuficiencia Cardíaca**.

En este sentido, los **criterios de derivación a Cardiología** con diagnóstico de sospecha o diagnóstico confirmado de IC son:

- Confirmación del diagnóstico de sospecha de IC en pacientes jóvenes sin claros factores desencadenantes.
- Progresión clínica del estado funcional (GF III o IV)

- Falta de respuesta al tratamiento con dosis altas de furosemida
- Sospecha de una nueva cardiopatía asociada (por ejemplo, cardiopatía isquémica)
- Descompensación sin un claro factor abordable desde Atención Primaria
- Optimizar el tratamiento en pacientes difíciles (“ajuste de tratamiento)
- Deterioro de la función renal (Creatinina sérica > 2.25 mg/dl)
- Alteraciones bioquímicas graves, como sodio < 129 mEq/l o potasio elevado > 5.5 mEq/l.
- Presión arterial sistólica baja (< 90 mmHg) que limite las opciones terapéuticas.

Toda solicitud de Teleconsulta con Cardiología en pacientes cuyo motivo de consulta sea Insuficiencia Cardíaca, deberá contar con:

- Anamnesis y exploración completa.
- Rx tórax y EKG reciente
- Analítica que incluya hemograma, glucosa, función renal e iones, transaminasas, perfil lipídico y hormonas tiroideas, además de **NTproBNP, que en caso de presentar un valor negativo, no procedería la derivación**, y si un estudio etiológico distinto de los síntomas del paciente.

2.- FIBRILACIÓN AURICULAR

La Fibrilación Auricular (FA) es la alteración sostenida más común del ritmo cardíaco y son los médicos de Atención Primaria los que tienen la oportunidad de buscar activamente a estos pacientes, en muchas ocasiones asintomáticos, mediante un cribado oportunista (toma de pulso) o directo en los pacientes de alto riesgo, pudiendo así evitar casos de ACV u otras complicaciones cardiovasculares.

Los objetivos generales del tratamiento de la FA son reducir la morbimortalidad y mejorar la calidad de vida. Estos objetivos deben perseguirse de forma paralela, particularmente en los casos de FA de nueva detección y se basan en el control de la frecuencia cardíaca y la prevención de las complicaciones mediante el empleo de tratamiento antitrombóticos

En ocasiones, el tratamiento de los síntomas (si no mejoran con el control de la frecuencia cardíaca) puede justificar la indicación de otras intervenciones para el control del ritmo cardíaco, como cardioversión, fármacos antiarrítmicos, ablación o cirugía.

Clasificación de la fibrilación auricular

La fibrilación auricular se va a clasificar, en función de su persistencia en el tiempo y de que hayan sido diagnosticada con anterioridad o no en:

Patrón de FA	Definición
FA diagnosticada por primera vez	La FA no ha sido diagnosticada antes, independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y la gravedad de los síntomas relacionados con ella
FA paroxística	La FA se revierte espontáneamente o con una intervención en los primeros 7 días
FA persistente	La FA se mantiene durante más de 7 días, incluidos los episodios que se terminan por cardioversión farmacológica o eléctrica tras más de 7 días
FA persistente de larga duración	FA continua más de 1 año tras adoptar una estrategia para el control del ritmo cardiaco
FA permanente	El paciente y el médico asumen la FA y no se adoptan nuevas medidas para restaurar o mantener el ritmo sinusal. La FA permanente representa más una actitud terapéutica del paciente y el médico que un atributo fisiopatológico inherente a la FA. Este término no debe emplearse en el contexto de una estrategia para el control del ritmo con fármacos antiarrítmicos o ablación con catéter.

La derivación por Teleconsulta de los pacientes con FA, incluirá en todos los casos:

- Historia familiar de primer grado de antecedentes de cardiopatía o muerte súbita.
- Antecedentes personales de patologías relacionadas con aumento del riesgo cardiovascular o cardiopatía (EPOC/SAOS, DM, Obesidad, Dislipemia o HTA) así como la realización de deporte de alta intensidad y consumo de tóxicos
- Anamnesis detallada sobre los síntomas del paciente (disnea, dolor torácico, síncope o palpitaciones) y tiempo de evolución de la arritmia
- Exploración física, destacando la presencia o no de soplos o signos de congestión
- Pruebas complementarias:
 - EKG de 12 derivaciones y tira de ritmo, que **se enviará asociado a la teleconsulta mediante Captura.**
 - Analítica con hemograma, bioquímica básica, perfil lipídico y tiroidea y HBbA1c (en pacientes DM).
 - Rx de tórax.

- **Ecocardiograma**, en todos los casos de FA diagnosticada por primera vez (se adjunta procedimiento de solicitud)

Son candidatos a Teleconsulta con Cardiología por este motivo de consulta, en:

- Pacientes con sospecha de enfermedad cardiovascular subyacente.
- Pacientes jóvenes (< 65 años).
- Pacientes sintomáticos a pesar de un correcto control de la frecuencia cardiaca o con episodios repetidos de FA paroxística.
- Pacientes con FA diagnóstica por primera vez con alteraciones estructurales en la ecocardiografía.
- Pacientes con duda para el empleo de tratamiento anticoagulantes o manejo de antiarrítmicos.

3.- ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS

El electrocardiograma (EKG) es una prueba complementaria ampliamente utilizada en Atención Primaria y una de las herramientas de mayor utilidad en el diagnóstico de cardiopatías y alteraciones del ritmo, de fácil lectura e interpretación, pero que en ocasiones plantea dudas tanto en la interpretación como en el manejo de alteraciones en pacientes paucisintomáticos.

En este sentido, **son candidatos a realizar teleconsulta por alteraciones electrocardiográficas los pacientes con alteraciones en el EKG o dudas en su interpretación, presenten síntomas o no.**

La derivación por Teleconsulta por este motivo de consulta incluirá en todos los casos:

- Historia familiar de primer grado de antecedentes de cardiopatía o muerte súbita.
- Antecedentes personales de patologías relacionadas con aumento del riesgo cardiovascular o cardiopatía (EPOC/SAOS, DM, Obesidad, Dislipemia o HTA) así como la realización de deporte de alta intensidad y consumo de tóxicos
- Anamnesis detallada sobre los síntomas del paciente, y en su ausencia, la causa por la que fue realizado el EKG.

En el caso de duda en la interpretación del EKG, en este apartado hará referencia a la duda planteada.

- Exploración física, destacando la presencia o no de soplos o signos de congestión
- Pruebas complementarias:
 - EKG de 12 derivaciones, que **se enviará asociado a la teleconsulta mediante Capptura**. En el caso de dudas relacionadas con alteraciones del ritmo, es conveniente acompañarlo de una tira de ritmo.
 - Analítica con hemograma, bioquímica básica, perfil lipídico y tiroidea y HbA1c (en pacientes DM) y/o Rx de tórax, necesarias en pacientes sintomáticos.

EN RESUMEN:

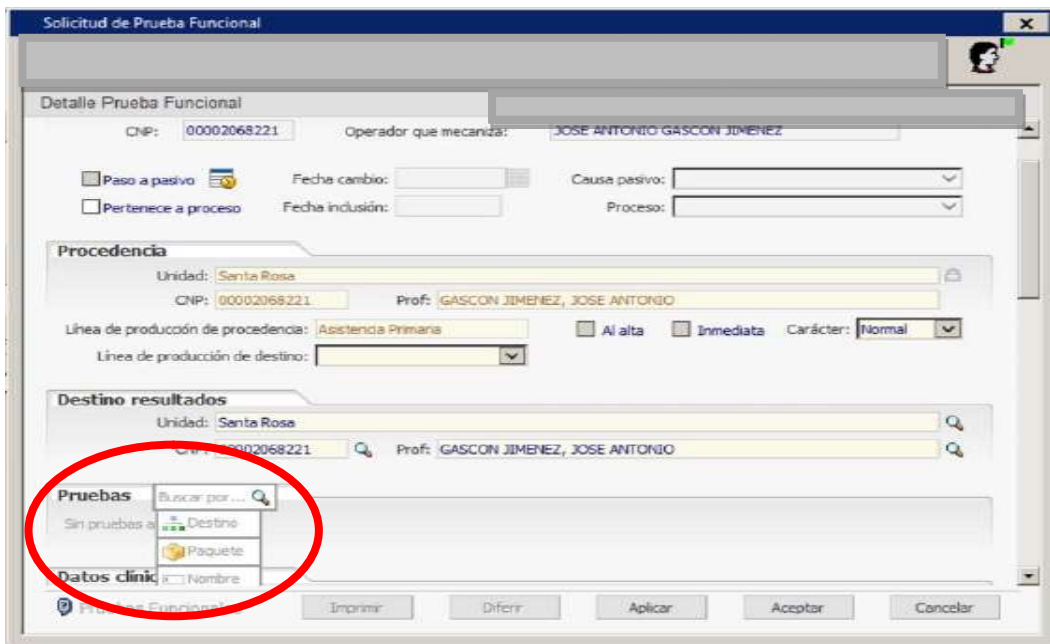
El objetivo de estos acuerdos es facilitar la consulta en acto único por parte del servicio de cardiología, mejorando su capacidad de resolución y accesibilidad a otros pacientes del SSPA.

Para ello, se establece que:

- 1.- Toda derivación a cardiología deberá realizarse con unos mínimos criterios de calidad en los que de forma inexcusable se informe del tiempo de evolución y el tratamiento empleado cuando proceda. La no inclusión de esta información en la derivación podrá ser motivo de devolución por falta de información.
- 2.- Toda sospecha de patología subsidiaria de ser valorada por cardiología o duda diagnóstica, será remitida para su valoración con los criterios antes mencionados. Tras la valoración, el servicio de cardiología emitirá en todos los casos un informe a través de Diraya, donde de forma inequívoca conste si se procede al alta o si procede revisión, en cuyo caso, será gestionada directamente por el servicio.
- 3.- Para los pacientes que tras su valoración se indique un tratamiento o recomendaciones para el paciente, todas las prescripciones necesarias se realizarán a través de la aplicación de RXXI, y en caso de precisar revisión, con fecha de validez hasta la siguiente revisión.
- 4.- Los pacientes que ya han sido valorados por un motivo de consulta concreto con informe de alta por parte del servicio de cardiología y en donde su médico de familia entienda que la evolución no es satisfactoria, se contactará con el cardiólogo de referencia por medios telemáticos, y en caso de consensuar una nueva valoración, esta se generará como revisión a través de la UAC.
- 5.- Si tras una consulta con cardiología, este determina que procede otra consulta con cualquier otro servicio hospitalario, esta se hará a través de Interconsulta Hospitalaria y no a través de Atención Primaria.
- 6.- El servicio de cardiología garantizará la comunicación telemática con los centros de atención primaria, nombrando referentes en cada uno de los centros y dando respuesta a las dudas y consultas solicitadas en el plazo establecido.
- 7.- El sistema de derivación por Teleconsulta cumple con todos los derechos de garantía en los tiempos de respuesta al paciente, por lo que su acceso desde Atención Primaria estará permanentemente operativo.
- 8.- El grupo de trabajo entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria mantendrá reuniones periódicas para valorar en cumplimiento de estos acuerdos.

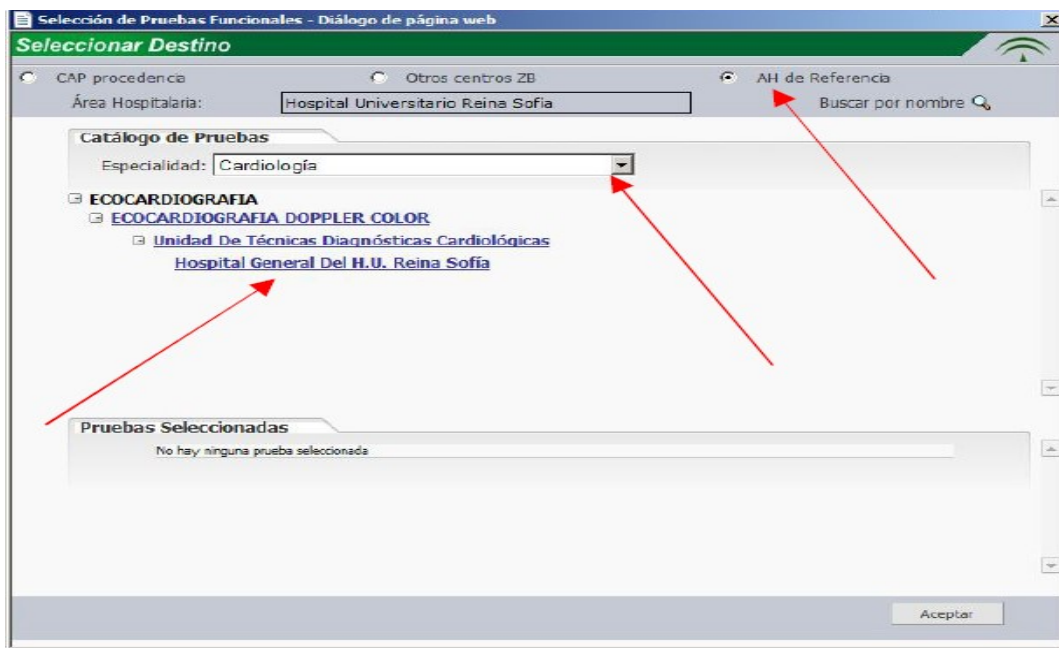
ANEXO 1: SOLICITUD DE ECOCARDIOGRAMA EN HISTORIA DE SALUD

La solicitud de ecocardiograma se hará a través de la opción de **pruebas funcionales** disponible en la HSC que mostrará al profesional la ventana para la petición. Una vez abierta, debemos ir a **pruebas** y dar a la opción **“buscar por”** y seleccionar **“destino”**



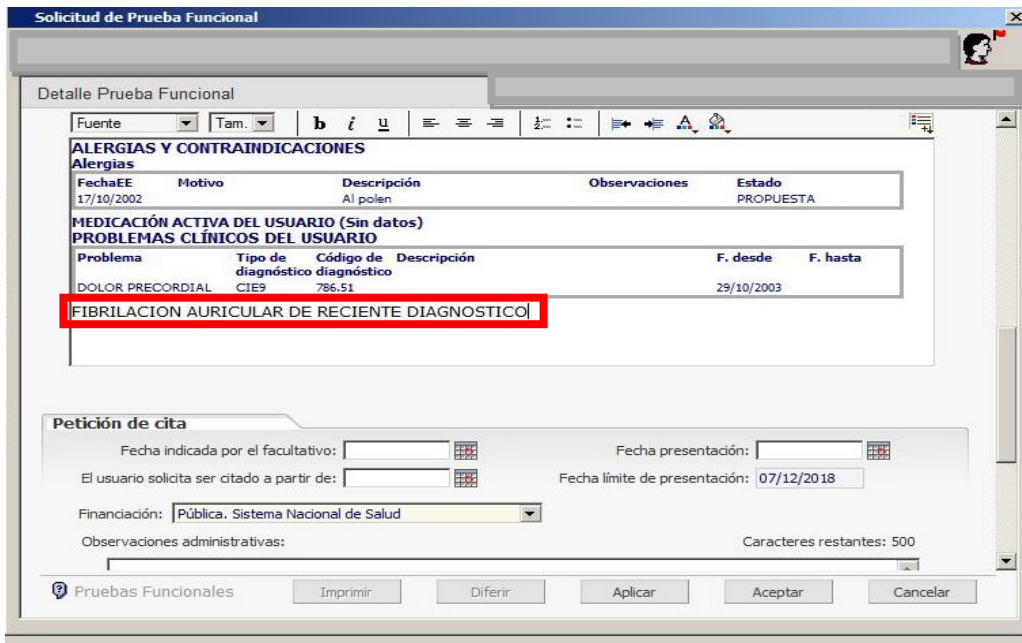
The screenshot shows the 'Solicitud de Prueba Funcional' window. The 'Pruebas' tab is selected, and the 'Buscar por...' dropdown menu is open, showing options like 'Destino' and 'Paquete'. The 'Destino' option is highlighted. The window also displays fields for 'CNP', 'Operador que mecaniza', 'Unidad', 'Prof', 'Línea de producción de procedencia', 'Línea de producción de destino', and 'Destino resultados'.

Esto nos abrirá una nueva ventana donde debemos **seleccionar** previamente **AH de referencia** y posteriormente **seleccionar el destino cardiología** que nos abrirá la solicitud de prueba



The screenshot shows the 'Selección de Pruebas Funcionales - Diálogo de página web' window. The 'AH de Referencia' tab is selected, and the 'Catálogo de Pruebas' section shows 'ECOCARDIOGRAFIA' and 'ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR' selected. Red arrows point to the 'AH de Referencia' tab, the 'ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR' option, and the 'Unidad De Técnicas Diagnósticas Cardiológicas Hospital General Del H.U. Reina Sofia'.

En el **motivo de solicitud** se indicará tal y como aparece en la ficha:
“FIBRILACION AURICULAR DE RECIENTE DIAGNOSTICO”



La mecánica de funcionamiento, una vez seleccionada la prueba es exactamente igual que en el caso de interconsultas.

IMPORTANTE: SE SOLICITARÁ ECOCARDIOGRAFIA CUANDO EL PROFESIONAL DE AP, EN CASO DE AUSENCIA DE CARDIOPATIA ESTRUCTURAL, ASUMA EL TRATAMIENTO ANTIARRITMICO Y/O ANTICOAGULANTE